

Notas del orador

Presentación al Comité Comercial · Mismas visitas, 2,44 M€ más al año · 20 minutos y preguntas

SLIDE 1 DE 8

Mismas visitas, 2,44 M€ más al año

En una frase: llevamos tres años con la misma regla de visitas; los datos dicen que se satura, y recolocar un tercio de las visitas vale 2,44 M€ al año sin tocar plantilla ni coste. Veinte minutos: diagnóstico, evidencia, plan y valor.

SLIDE 2 DE 8

El esfuerzo sigue al potencial, pero se satura: mover un tercio de las visitas vale 2,44 M€ al año sin coste

Tres ideas y un número. La segmentación no es el problema (30 de 2.000). El hallazgo es la saturación a partir de 8-10 visitas, igual en A, B y C. La recomendación cabe en una línea: 9-10 / 5 / 2 dentro de cada cartera. Si preguntan de dónde sale el 2,44, remitir a la slide 7.

SLIDE 3 DE 8

Hoy 276 médicos reciben diez o más visitas al año y 509 no reciben ninguna

La regla $A > B > C$ se cumple con intensidad: un A recibe nueve veces más visitas que un C. El porcentaje de visitas de cada segmento es casi igual a su porcentaje de categoría, así que el problema no es el reparto entre segmentos sino los extremos: 276 médicos con diez o más visitas y 509 con ninguna. Los 255 duplicados se eliminaron; con ellos el valor sube a 2,48 M€.

SLIDE 4 DE 8

A partir de 8-10 visitas al año, una visita más apenas mueve la cuota, sea el médico A, B o C

Por qué primeras diferencias: comparar a cada médico consigo mismo elimina que se visite más a quien ya prescribía. La curva es $\text{cuota} = \text{base} + D \cdot v / (v + h)$, con $D = 0,159$ y $h = 2,5$ visitas; ajustada por segmento da parámetros parecidos y explica el 90 % de los cambios de cuota. Límite: los médicos que se empezaron a visitar en 2025 ya tenían 16,4 % frente a 12,4 %; por eso el resultado va con rango.

SLIDE 5 DE 8

La décima visita a un médico A vale 613 €; la primera a un B sin visitar, 3.833 €

El valor de una visita es volumen $\times$ ganancia de cuota $\times$ 18 €. La ganancia depende de cuántas visitas ya recibe el médico, por eso la décima a un A (613 €) vale menos que la primera a un B (3.833 €) aunque el A tenga más del doble de volumen. Buscar en la tabla un valor parecido en las tres columnas (600-700 €) da la regla 9-10 / 5 / 2 antes de optimizar nada.

SLIDE 6 DE 8

Plan 2026: 9-10 / 5 / 2 visitas al año, ajustadas por volumen, dentro de la cartera de cada delegado

La asignación es médico a médico con el volumen real de categoría, por eso hay rangos. Primero se calculó un óptimo global (2,50 M€) y luego uno por delegado (2,44 M€) para que sea ejecutable sin tocar territorios. Por deciles de volumen, se quitan visitas a los dos deciles más altos y se ponen en los deciles 3 a 8; el valor neto se concentra en los B grandes. Fase 1 posible: 184 médicos y 982 visitas capturan la mitad del valor.

SLIDE 7 DE 8

+2,44 M€ al año a coste cero: la cuota pasa del 19,9 % al 21,5 %

El número que se defiende es el rango, no el punto: 2,44 M€ es el techo con todo a favor; 1,5 M€ se supera en 93 de cada 100 escenarios prudentes. Peor caso razonable: 1,22 M€ si solo se materializa la mitad del efecto. Los rangos de causalidad (60-100 %) y ejecución (70-100 %) son juicio y se pueden discutir en la sala; el modelo los recalcula en segundos.

SLIDE 8 DE 8

Qué no dicen los datos y qué haríamos si cambia la premisa

Límites: selección moderada, sin datos de competencia, efecto simétrico asumido y respaldado.

Extensión: cada visita extra vale 577 € frente a 72 € de coste; el modelo responde a cambios de

capacidad o territorio en minutos. Piloto: seis meses en una región bastan por el bajo ruido mensual (1,9 puntos).